

殿

年 月 日 説明者:耳鼻咽喉科医師 高橋克昌

●慢性中耳炎とは

鼓膜に穴が開いた状態です。太鼓の皮に穴が開くと音が鳴らないのと同じです。鼓膜の後ろは鼻の粘膜につながっています。風邪をひいた時など、鼻水と同じように耳から膿が出てきます。耳漏がでると鼓膜の穴は大きくなり、難聴も進みます。

およそ半数の成人は、子供の頃に急性中耳炎になり、耳漏を経験します。大半は小さな鼓膜の穴なので、自然に閉鎖しますが、まれに閉じないで穴が開いたままの人がいます。または中耳炎の治療のために、耳鼻科で鼓膜を切開したり、チューブを留置する処置を受けた後、穴が残ることもあります。殴られて鼓膜に穴が開くこともあります。

●慢性中耳炎の症状と治療

難聴の種類には、鼓膜や耳小骨が原因の伝音難聴と、音を感じる神経が原因の感音難聴とがあります。伝音難聴では手術できますが、感音難聴は手術では治りません。長年、耳漏が続くと神経が障害されて、伝音難聴に感音難聴が加わります。手術の効果が少なくなります。

手術で完全に穴を閉鎖すれば、耳漏は治ります。

逆に、難聴もなく耳漏もない鼓膜の穿孔は手術でふさぐ必要はありません。

●診断と治療に必要な検査

ファイバーや顕微鏡で**鼓膜穿孔**を確認します。**側頭骨CT**で炎症の広がり具合を確認したり、耳小骨の破壊がないか調べます。

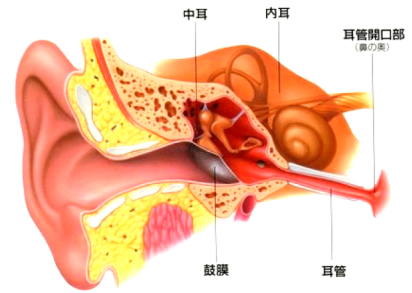
鼓膜の穴に濾紙をあてがって聴力が上昇するか検査します(**パッチテスト**)。これで聴力が改善する場合は、手術で聴力が回復する可能性があります。**細菌検査**で抗生剤のきき具合を調べて、術後に使う薬を選択します。

●治療について

穴の閉鎖には手術が有用ですが、作られた厚い鼓膜は元の鼓膜ほどには聞こえません。難聴の程度が軽い場合は、手術しても変わらないと感じる人もいます。

耳漏に対しては、手術前の除菌が大切です。膿だらけの場所にメスをいれても、手術の成功率は下がります。手術前に頻回の通院が必要です。

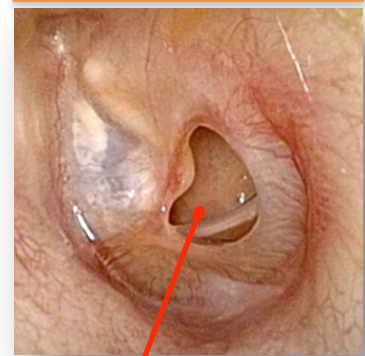
術後に感染して、再び鼓膜に穴が開くことも多く、次に紹介する簡便法(湯浅法)での成功率は70%程度、大掛かりな鼓室形成術でも90%程度です。大きな鼓膜穿孔では、簡便法では失敗するので、はじめから鼓室形成術を勧めます。



正常鼓膜・左耳



慢性穿孔性中耳炎



鼓膜穿孔



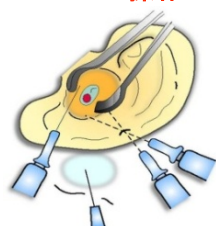
パッチテスト



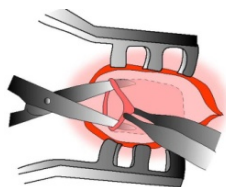
●鼓膜形成術（湯浅法）

小さな鼓膜穿孔で、パッチテストで聴力が改善する場合に適応です。①耳の穴（外耳道）から行い、局所麻酔でもできます（やや痛いです）。②穴をふさぐ材料として、皮下組織や側頭筋の筋膜を髪の毛の生え際を切って採取します。③穿孔の縁をきれいに整えて、④鼓膜の裏側に膜を張ります。ズボンの穴を裏からパッチワークでふさぐ方法に似ています。

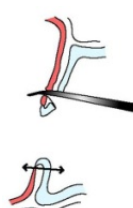
① 外耳道経由での操作



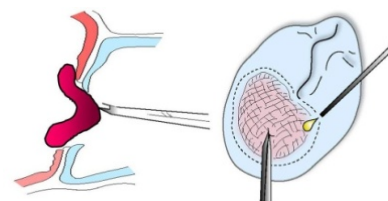
② 組織の採取



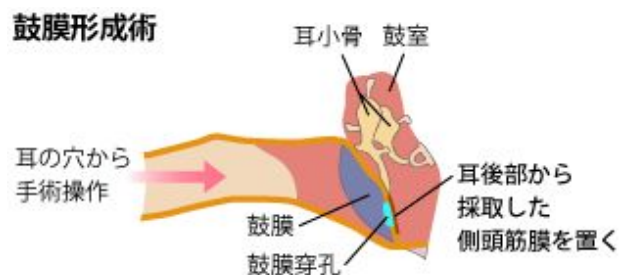
③ 穿孔縁の新鮮化



④ 穿孔の閉鎖と固定



鼓膜形成術

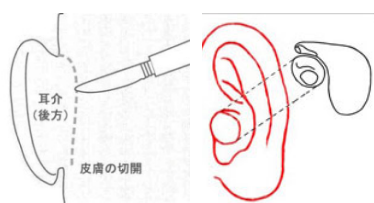


●鼓室形成術

パッチテストで聴力が改善しない場合、耳小骨も障害されている可能性があり、鼓膜の奥を操作する必要があります。穴が大きく、湯浅法ではふさげない場合もあります。

①耳の後ろを大きく切開し、②穿孔鼓膜は2枚おろしにします。中耳の病変は清掃し、耳小骨も修復します。閉鎖材料は筋膜や薄切りにした軟骨を使います。③2枚おろしにした穿孔鼓膜の間に筋膜をサンドイッチします。④耳の穴の皮膚を戻して耳後部を縫合します。

①耳後切開と 耳介・鼓膜の位置関係



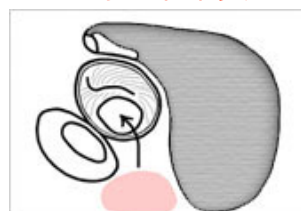
②穿孔鼓膜を二 枚おろし

鼓室形成術

I型

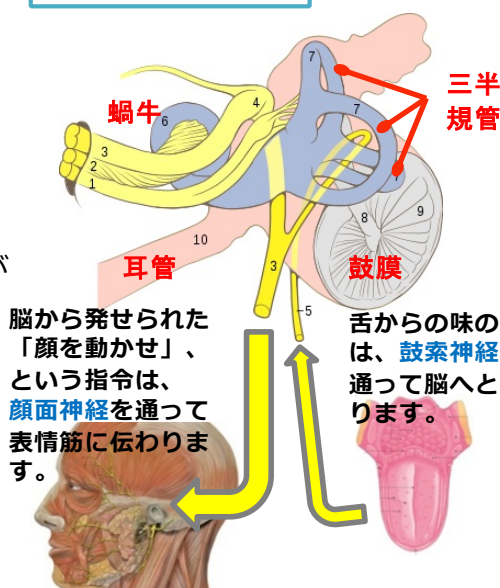


③筋膜を サンドイッチ



④おろした鼓膜を戻す

中耳腔と内耳、神経



●鼓室形成術の合併症

出血や創感染等一般的な合併症の他に、脳とつながる耳に特有の症状がでることがあります。

- ・ 術側の舌前の味覚低下（鼓索神経の障害）
- ・ 感音難聴や耳鳴（頭蓋骨を削る音が刺激になる）
- ・ めまい（三半規管の障害）
- ・ 術側の顔が麻痺（顔面神経の障害）
- ・ 頭蓋内合併症（脳の炎症や髄液漏など）
- ・ 静脈洞からの大量出血 など